

Tolerancja i odstawienie

Dwa zjawiska, które odróżniają „nadużywanie” od „uzależnienia fizjologicznego”. Mózg się adaptuje — i ta adaptacja boli, gdy zabraknie substancji.

CZAS: 25 min czytanie Psychoedukacja — bez skali

ŹRÓDŁO: Koob & Volkow (2016); APA DSM-5-TR (2022); WHO ICD-11 (2022)

JAK UŻYWAĆ

Karta porządkuje wiedzę o **dwóch fizjologicznych zjawiskach**: *tolerancji* (potrzeba większych dawek dla tego samego efektu) i *odstawieniu* (objawy somatyczne i psychiczne po zaprzestaniu używania). Po przeczytaniu zaznacz, które objawy znasz z własnego doświadczenia. To *nie diagnoza* — to mapa zrozumienia. **Uwaga:** niektóre objawy odstawienia (alkohol, benzodiazepiny, opioidy) mogą być **medycznie groźne** — wymagają nadzoru lekarskiego.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Tolerancja i odstawienie to **fizyczne dowody neuroadaptacji** — mózg dosłownie się zmienia w odpowiedzi na powtarzającą się ekspozycję na substancję. Zrozumienie tych zjawisk: 1) *tłumaczy*, dlaczego pacjent „nie może po prostu przestać” (mózg adaptowany na obecność substancji *cierpi* bez niej), 2) *uświadamia ryzyko* samodzielnego odstawienia (drgawki, majaczenie, depresja samobójcza — ryzyko śmierci do 5% w ciężkim DT bez leczenia), 3) *wskazuje konieczność konsultacji lekarskiej*. APA DSM-5-TR (2022): tolerancja i objawy odstawienne to 2 z 11 kryteriów zaburzenia używania substancji.

01 Tolerancja — co to znaczy i jak się rozpoznaje

DEFINICJA

Spadek wrażliwości na substancję w wyniku regularnego używania. **Ta sama dawka daje słabszy efekt** → trzeba *więcej*, by uzyskać dawne wrażenia. Mechanizm: regulacja receptorów w dół, zmiany metabolizmu wątrobowego.

TRZY RODZAJE TOLERANCJI

Metaboliczna — wątroba szybciej rozkłada substancję.

Komórkowa — receptory mózgowe stają się mniej wrażliwe.

Behawioralna — uczę się „funkcjonować pod wpływem” (np. picie nie wpływa już na koordynację).

Pułapka tolerancji odwróconej: u zaawansowanych alkoholików tolerancja *spada* — wątroba uszkodzona, mniej enzymów, dawka która kiedyś nie robiła wrażenia teraz powoduje pełne upojenie. To **nie jest wyzdrowienie** — to objaw uszkodzenia. Wymaga konsultacji.

02 Odstawienie — objawy somatyczne i ryzyko

SUBSTANCJA	GŁÓWNE OBJAWY ODSTAWIENIA	CZAS + RYZYKO MEDYCZNE
Alkohol	Drżenie, pocenie, lęk, nudności, halucynacje, drgawki, majaczenie alkoholowe (DT)	6-72 h. DT: ryzyko śmierci 5%
Benzodiazepiny	Lęk, bezsenność, drżenia, drgawki, psychoza odstawienna	2-10 dni. Drgawki: ryzyko
Opioidy	Ból mięśni, biegunka, wymioty, gęsia skórka, dysforia, bezsenność	12-72 h. Nieprzyjemne, rzadko śmiertelne
Stymulanty	Hipersomnia, głód, dysforia, anhedonia, myśli samobójcze	7-14 dni. Ryzyko samobójstwa
Kannabinoidy	Bezsенność, drażliwość, lęk, spadek apetytu, pocenie	1-4 tyg. Niskie ryzyko medyczne

03 ✕ Kiedy konieczna konsultacja medyczna

Niektóre odstawienia są **medycznie groźne** — wymagają nadzoru lekarskiego, czasem hospitalizacji. Sygnały, że konieczna jest konsultacja *przed* próbą abstynencji w domu:

⚠ Picie codziennie ≥ 4 lat lub ≥ 4 drinki/dzień przez 6 mies. — wysokie ryzyko ciężkiego AWS

⚠ Wcześniejsze drgawki / majaczenie po odstawieniu

⚠ Regularne benzodiazepiny ≥ 3 mies. — ryzyko drgawek

⚠ Współistniejące choroby — serce, wątroba, padaczka, ciąża

⚠ Współistniejąca depresja / myśli samobójcze (zwł. po stymulantach)

⚠ Samotne mieszkanie — brak nadzoru na pierwsze 72 h

Gdzie szukać pomocy: oddziały detoksykacyjne (NFZ, bezpłatne) · lekarz POZ (skierowanie) · linia uzależnień 800 199 990 (bezpłatna, 24h) · informacja: uzaleznieniabehawioralne.pl, kbpn.gov.pl.

04 ✎ Mój wzorzec — autorefleksja

CZY ZAUWAŻAM TOLERANCJĘ?

— czy potrzeba więcej dla tego samego efektu

CZY MAM OBJAWY ODSTAWIENNE?

— jakie i jak długo

Klucz: obecność tolerancji i odstawienia **nie jest definicją uzależnienia** (osoba z chronicznym bólem na opioidach też ma tolerancję, ale niekoniecznie uzależnienie) — ale są to *silne markery zaawansowania*. APA DSM-5-TR (2022) klasyfikuje zaburzenie używania substancji jako łagodne (2-3 kryteria), umiarkowane (4-5) lub ciężkie (≥ 6). Sama tolerancja + odstawienie to już 2 kryteria. Ciężkie uzależnienie z fizjologicznym komponentem **zwiększa potrzebę farmakoterapii** jako pierwszej linii leczenia (Mark i wsp. 2019, *Substance Abuse*): leki zmniejszają ryzyko nawrotu o 30-50% u osób z fizjologicznym uzależnieniem.